EDN · RÉVISION MÉDICALE

Nutrition-Activité physique

Révision médicale complète · 7 chapitres · 7 illustrations

EDN

Informations

EDN — Nutrition-Activité physique

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Dyslipidémie (223)

2 Obésité (253)

3 Dénutrition (250)

4 Amaigrissement (251)

5 Modifications thérapeutiques du mode de vie (248, 249)

6 Aptitude au sport, Besoins nutritionnels chez le sportif (256)

Références

Pas de collège en ligne - Masson de Nutrition et activité physique à faire une fois sur Clinical Key

Dyslipidémie (223)

> *Items 222 & 223 – Facteurs de risque cardiovasculaire, prévention - Dyslipidémies - Société Française d'Endocrinologie*

> *Chapitre 3 Item 223 Dyslipidémies | Société Française de Cardiologie*

Introduction

Rappels : Lipoprotéines

Rôle. Particules en charge du transport des lipides dans le plasma

Chylomicrons. Synthétisés dans la cellule intestinale, transportent les lipides d'origine alimentaire

VLDL

IDL

1. Very low density lipoproteins : synthétisées par le foie, transporte les lipides d'origine endogène (produits par le corps)
2. Intermediate Density Lipoproteins : résulte de l'hydrolyse des VLDL

LDL

1. Low density lipoproteins résulte de l'hydrolyse des IDL
2. Transporte le cholestérol dans le foie ou du foie vers les cellules périphériques, en se fixant sur un récepteur spécifique

(LDL-récepteur qui est sous le contrôle de la **PCSK9 qui diminue le nombre de LDL-R à la surface de l'hépatocyte**)

HDL. High Density Lipoproteins sont produites par le foie, qui jouent un rôle essentiel dans la captation du cholestérol dans les tissus périphériques pour le rapporter au foie en vue de sa dégradation (voie de retour du cholestérol)

Lipoprotéine lipase

Lipoprotéine lipase dégrade les triglycérides au sein des chylomicrons et des VLDL

(déficitaire dans hyperchylomicronémies primitives familiales : types 1 et 5)

Précisions sur la relation Dyslipidémie/Athérosclérose

Anomalies athérogènes

Morbidité-Mortalité cardio-vasculaire est associée à :

- Augmentation du LDL-cholestérol (LDLc = mauvais cholestérol, athérogène)
- Augmentation des triglycérides (TG, rarement isolée) : FR moins puissant que augmentation des LDLc
- Diminution du HDL-cholestérol (HDLc = bon cholestérol, protège du risque d'athérome) :
  - Diminution **< 0,4 g/L** chez l'homme, **< 0,5 g/L** chez la femme
  - **Marqueur de risque indépendant puissant** (en revanche des données récentes suggèrent le contraire)